4.影像学（不是必须的）

①超声（首选影像学）：阑尾肿大等

②X 线：可见液气平 液气平不一定是梗阻(液体气体排不走)
也有可能是腹泻导致(液体气体来太多)



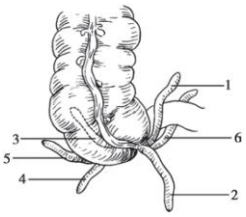


图 40-1 阑尾的解剖位置

1. 回肠前位 2. 盆位 3. 盲肠后位 4. 盲肠下位
5. 盲肠外侧位 6. 回肠后位 腹膜后位

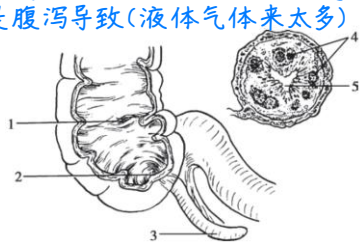


图 40-2 阑尾的解剖

1. 回盲瓣 2. 阑尾开口 3. 阑尾 4. 淋巴组织
5. 阑尾腔

二、发展和治疗

（一）单纯性（早期）



①症状轻、无肌紧张

②切阑尾（**麦氏点切口**），不冲腹腔、不放引流

（二）化脓性（蜂窝织炎）



Fig. 48.1 Sudden perforation, especially if engendered by purgation, often results in an immediate, widespread bacterial peritonitis.

①**局限性腹膜炎**（局部压痛/反跳痛/肌紧张），阑尾腔内积脓

②脓液少→纱布沾干渗液后切阑尾（**麦氏点切口**），不冲腹腔、不放引流

③**脓液多→生理盐水冲腹腔**后切阑尾（**麦氏点切口**），**根据情况放引流**
引流管属于异物增加腹腔感染几率,同时在脓液粘稠时更容易形成粘连

（三）坏疽穿孔性（阑尾动脉是终末动脉）没有侧支循环,容易缺血坏死

①阑尾呈暗紫色，腹痛可暂时减轻、但随即**弥漫性腹膜炎**（全腹压痛/反跳痛/肌紧张），体温进一步升高、肠鸣音↓、甚至休克
毒素吸收入血

②**生理盐水冲腹腔**后切阑尾（**右下腹经腹直肌切口**），**根据情况放引流**
抗生素容易导致粘连 方便探查

腹部损伤急诊剖腹探查:正中切口
腹腔感染继发腹膜炎:右旁正中切口
单纯性、化脓性阑尾炎:麦氏点切口
坏疽穿孔阑尾炎:右下腹直肌切口

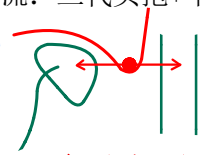
（四）腹盆腔脓肿

1.阑尾周围脓肿

①**右下腹包块**：波动感、压痛、边界不清、活动度差 不一定是肿瘤

②可致瘘管形成→及时放引流：三代头孢+甲硝唑、**穿刺/置管引流**，若脓肿扩大行**手术切开引流**
此时阑尾周围是大网膜包起来的引流液,找不到阑尾

③**3 个月后切阑尾** 阑尾重现



2.盆腔脓肿

①**肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和/或膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）**

②**首选直肠指检**：直肠前壁有触痛的波动性肿块

③直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流、三代头孢+甲硝唑



3.膈下脓肿（负压）膈神经麻痹的表现

①上腹痛、ttsx 呃逆、膈肌抬高、胸膜炎

②首选 B 超